

מעכב ישיר של תרומבין | IV | זמן מחצית חיים קצר | onset מהיר | ללא antidote

מבוא

Bivalirudin הוא מעכב ישיר של תרומבין הניתן IV, בעל זמן מחצית חיים קצר ו-onset מהיר, ללא antidote. ניתן במספר התוויות, כולל טיפול נוגד קרישה במטופלים שפיתחו HIT תחת טיפול בהפרין, וכן בניתוחי לב ובמטופלים העוברים PCI.

מינונים מומלצים

תכשיר יינתן על פי המלצתו ובאישורו של מומחה לקרישה בלבד (מלבד מחלקות טיפול נמרץ).

- מינון התחלתי: עירוי מתמשך בקצב 0.1 mg/kg/hr.
- טווח מינונים במטופלי PCI בלבד: 0.1-0.35 mg/kg/hr.
- במטופלים עם אי-ספיקה כבדית או סיכון גבוה לדימום יש לשקול מינון התחלתי נמוך יותר; בכל מקרה יש להתייעץ עם כונן קרישה.

CrCl (Creatinine Clearance) >30 mL/min: מינון 0.04–0.07 mg/kg/hr.

הכנה ומתן

- כל בקבוקון מכיל 250 mg של Bivalirudin באבקה.

המסה	להוסיף 5 mL מים סטריליים להזרקה (SWFI) ולנער בעדינות עד להמסה מלאה. התמיסה המומסת יציבה עד 24 שעות בקירור 2-8°C; אין להקפיא.
דילול מלא	לדלל את כל תכולת הבקבוקון (250 mL = 5 mg) בעזרת NS לנפח כולל של 50 mL.
דילול למינון נמוך	במינון נמוך (>125 mg): להשתמש במחצית התמיסה המהולה בבקבוקון (125 mg = 2.5 mL) ולדלל בעזרת NS לנפח כולל של 25 mL.
מתן	ריכוז סופי 5 mg/mL. מתן בעירוי תוך-וריד, דרך שאיבת/לומן נפרד בלבד לפי הפרוטוקול המחלקתי.

- ניטור השפעת התרופה ייעשה לפי ערכי aPTT.
- ערך ה-aPTT הרצוי: פי 1.5-2.5 מרמת הבסיס.
- לאור זמן מחצית החיים הקצר של התרופה, יש לבדוק aPTT כשעתיים לאחר התחלת הטיפול.
- בדיקות ניטור חוזרות יילקחו 2-4 שעות לאחר שינוי מינון עד התייצבות הערכים בתחום הטיפולי הרצוי, ובהמשך אחת למשמרת.

במקרה של דימום חד יש להפסיק מיידית את העירוי ולהתייעץ עם מומחה קרישה.

אינטראקציות ואזהרות

- יש להימנע ככל האפשר משילוב עם תרופות אחרות שעלולות להגביר סיכון לדימום.
- יש לתת את התרופה בלומן נפרד. אם אין אפשרות ללומן נפרד, יש ליצור קשר עם בית המרקחת.

סימוכין

1. "Angiomax" prescribing information, March 2016, FDA.
2. Bivalirudin drug information, UpToDate 2021.
3. Linkins LA et al. Treatment and Prevention of Heparin-Induced Thrombocytopenia: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis. Chest. 2012;141(2 Suppl):e495S-e530S.
4. Heparin-Induced Thrombocytopenia (HIT) Treatment, MD Anderson Cancer Center, 2020.